의료진 진료 카드 · ASL-053

fT4 저하인데 TSH가 정상이라면

검사 간섭과 중추성 갑상선기능저하증(central hypothyroidism)을 함께 평가한다.

정상 TSH만으로 중추성 저하증을 배제하지 않는다



교재 · 중추성 저하증의 TSH 분포

정상 TSH가 흔함	fT4가 낮을 때 TSH는 참고범위 내 84%, <0.2 mIU/L 8%, >3.5 mIU/L 8%로 소개했다.
증례 단서	출산 후 체중증가·부종·피로·생리불순, TSH 4.6 mIU/L(0.4~6.8), fT4 0.7 ng/dL(0.8~1.9)의 조합으로 제시했다.

교재 · 간섭 요인 점검

분석·시약	Macro-TSH, 비오틴, 이종친화항체·류마티스인자, 갑상선호르몬 자가항체, 항루테늄·항스트렙타비딘 항체, TSH 아형과 시약별 참고치 차이.
생리·임상	일중 변동, 헤파린·조영제·비타민 등 약물, 비갑상선 질환(NTIS) 및 회복기. LT4 복용 직후 fT4가 일시 상승하므로 검사일 채혈 후 복용한다.

연자 Q&A · 재검과 의뢰

지속적 fT4 단독 저하	TSH 정상이면서 fT4가 낮으면 상급병원에서 평가하도록 제안했다. 시약·정상치 설정 문제로 재검이 정상인 경우도 있다는 답변.
전문 평가	고립성 중추성 저하증은 드물어 다른 뇌하수체 기능 평가를 고려한다. 본강의는 복합 뇌하수체검사/TRH 자극검사·sellar MRI를 전문 평가 항목으로 소개했다.

뇌하수체가 정상이면 일차성 저하증 조절은 TSH 기준, 뇌하수체 이상이면 fT4 기준이라는 Q&A 답변이다. TFT 비정상만으로 갑상선 초음파를 일률 권유하지 않는다.